

32-L'Appareil Génital Masculin

Tu as la crête génitale qui est influencée par la migration des gonocytes qui vient de la vésicule viteline, qui va épaissir cet épithélium cellulomique postérieur et former ce qu'on va appeler l'hébauche de ta gonade. Le tissu qui est ici, c'est un tissu qui est gonflé par la migration des gonocytes qui vient de la vésicule viteline. Les gonocytes arrivent sur cet tissu épithélial et font proliférer, font gonfler. Ce tissu gonadique devient la crête génitale, futur ovaire ou futur testicule. J'ai cette liaison qui se fait au niveau de la crête génitale. Le canal de Wolff était déjà formé depuis le pronéfront, puis il a disparu. C'est un canal collecteur. Le mouvement qui est poussé latéralement, on ne voit pas la surrénale ici, mais qui est poussé ici, vient amener à la création d'un petit canal qu'on appelle le canal de Muller. Le canal de Muller et le canal de Wolff vont avoir une relation très importante pour le développement du système urogénital, génital homme et femme. C'est une coupe du péritone parietal postérieur, dans lequel on voit, un, ici, ce qu'on appelle les cordons corticaux, ou qu'on peut rappeler, les futurs testicules, la crête génitale. Là, vous avez le corps de Wolff avec ce qu'on appelle le canal de Wolff. Et là, latéralement, vous avez l'apparition de ce qu'on appelle le canal de Muller. En fait, chez l'homme, ça ne se développe pas si fort. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas poussé si latéralement. On dit que le canal de Wolff se différencie en canal déférent et par bourgeonnement en uretère chez l'homme. Il y a un lien avec ce canal qui était créé au départ, qui était le canal de Wolff, qui va se connecter avec la zone testiculaire, si tu veux, en développement, avec la zone albunigée, et ça va faire des liens qui vont former le petit canal ici qu'on appelle le canal de Wolff, l'épididyme. Puis ici, on va avoir un ligament qui est important, qui est le ligament gubernaculum testi. Et puis, on voit ici que ça va se continuer avec le canal déférent pour continuer, pour former la vésicule séminale et le canal éjaculateur. Tandis que le canal de Muller ici, il régresse, mais il va

juste laisser une petite boule ici là-haut qu'on appelle l'idatite sessile. Ça n'a pas de fonction à ma connaissance, qui est un vestige. Ça régresse, par contre, ce qui est important, c'est qu'elle va donner ce qu'on appelle l'utricule prostatique, qui plus tard sera encore englobée par un autre tissu endodermique pour former cette prostate, qui sera reliée plus tard avec le système des canaux déférents qui, eux, viennent du canal de Wolff. Chez la femme, ça va former à la fois les trompes et l'utérus. Et chez l'homme, ça va juste former une partie de sa prostate. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que tout se dirige vers ta ligne médiane. Au niveau de l'utérus, ça s'organise comme ça. Par contre, sur le plan testiculaire, tu as un ligament gubernaculum qui se raccourcit, qui ne se développe pas ici. Et donc, le système va tirer. Les testicules vont être maintenues vers le bas, si tu veux, par rapport au système qui s'allonge. Et donc, il y a comme une force de descente qui est par rapport au développement de la gonade. Donc, la gonade, si tu veux, elle est maintenue par le bas, mais comme ça grandit, ça part comme ça. Par les vitesses de croissance différentielle de la partie postérieure, elle va suivre le développement et vient se déposer vers le bas. Chez les testicules, ça va être la même chose. Ça va être le gubernaculum avec le ligament anguinale qui va amener le système vers le bas. Ça veut dire que c'est suspendu jusqu'au niveau diaphragmatique au départ. Mais le tout repoussé au départ encore par mon mouvement hépatique. Donc, ce mouvement hépatique, non seulement il organise toute la cavité péritoneale, mais d'une certaine façon, il va organiser tout votre mouvement du développement urogénital. Donc, l'importance de ce foie, à la fois dans sa fonction métabolique et à la fois dans sa fonction embryonnaire. Ce petit vestige ici, c'est un vestige de ceci. C'est ce qu'on appelle l'utricule postatique. C'est le sein du canal de Muller. Là-dedans, c'est du tissu pithéal du tissu urogénital, c'est-à-dire endodermique. Et la prostate, elle va se développer à

partir de ce tissu. C'est le même tissu que le... Ça veut dire que l'utricule prostatique, donc le cœur de la prostate, c'est du mésenchyme. Et l'enveloppe autour la capsule, dit la prostate, c'est de l'endoderme. Qui vient du sinus urogenital. C'était là où tu avais le cloaque, l'allantoïde et le rectum derrière encore. Et avec la rencontre qui part pour former le bourgeonnement urétérique. Pour induire le rein définitif. Qui vient du canal de Wolff. Par rapport à cette testicule qui était au départ très haute, avec ce qu'on appelle le gubernaculum ici. Cette descente testiculaire qui se fait ici. Ce ligament ne se développe plus. Et donc par la croissance, il tire le système ici. Tandis que l'autre ligament s'allonge. Relativement par rapport au péritoine pariétal postérieur. On l'appelle ici le ligament suspenseur ovarien. Mais en fait c'est le ligament suspenseur gonadique. Qui est un ligament en rapport avec le diaphragme. Ligament suspenseur diaphragmatique. Ou bien ligament suspenseur testiculaire. ligament suspenseur ovarien. Cette attache ici avec le ligament gubernaculum qui vient se mettre sur la partie inférieure et les différentes couches que je ne retrouve plus, par la croissance, ça provoque ce phénomène-là. En fait, c'est une vitesse de croissance globale de ceci, de ce ligament, qui a l'air de réduire, mais c'est tout le reste qui grandit. C'est comme ça que vous avez la descente testiculaire. C'était suspendu par le ligament suspenseur testiculaire ou diaphragmatique. Donc ça veut dire qu'il faut aller revoir jusque sur le plan diaphragmatique et plus précisément sur le carrefour duodéno-pancréatique.